

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WILKIN WERKSCHAFTUNG
Kennzeichen/Fundstelle: IV.2	Bezeichnung des Dokumentes: Pflegekonzept	

Pflegekonzept

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Geschäftsführer: Egbert Schindler

QMB: Herr Diebner (Pflegedienstleitung)
Renate Rösler (stellvertr. PDL)
& Frau Zapke (Verwaltung)

Büro: Uhlandweg 10, 04316 Leipzig

Telefon: 03493 / 82 38 868 (24 Stunden Rufumleitung)

Fax: 03493/ 82 39 882

Funk: 0177/ 5969655 (24 Stunden)

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Seite	Version	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	003	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LERNEN WERTSCHÄTZUNG
Kennzeichen/Fundstelle: IV.2	Bezeichnung des Dokumentes: Pflegekonzept	

Punkt	Inhalt	Seite
0	Vorwort	2
1	Kurzworstellung der Intensivpflege/Darstellung von Räumlichkeiten	4
2	Zielgruppen, Aufnahme- und Ausschlusskriterien, Leistungsbeschreibung, Kooperationen	4
3	Pflege theoretische Grundlagen, unser Pflegemodell	4
4	Pflegeleitbild unseres Pflegedienstes	9
5	Angaben zur Pflegeorganisation, unser Pflegesystem Bezugspflege, Aussagen zur personellen Ausstattung	10
6	Umsetzung des Pflegeprozesses	10
7	Aufbau- und Ablauforganisation und innerbetriebliche Kommunikation, ständige Erreichbarkeit	13
8	Einbeziehung von Angehörigen in die Pflege und Betreuung	14
9	Angaben zum Qualitätssicherungssystem	15
10	Fort- und Weiterbildung	18
11	Literaturnachweis	20

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Seite	Version	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		2	003	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LERNEN VON UNSERER WERTSCHÖPFUNG
Kennzeichen/Fundstelle:	Bezeichnung des Dokumentes:	
IV.2	Pflegekonzept	

0. Vorwort

Das vorliegende Pflegekonzept definiert das pflegerische Angebot unseres Intensivpflegedienstes und ist Handlungsorientierung für alle Mitarbeiter, die am Pflegeprozess beteiligt sind. Vorrangig präzisiert es Zielsetzungen und regelt Organisation und Arbeitsweise des Intensivpflegebereiches und der pflegerischen Mitarbeiter.

Basierend auf dem Pflegeleitbild bietet es eindeutige Aussagen darüber, nach welcher Pflege Theorie in unserer Einrichtung gehandelt werden soll. Das schriftlich fixierte Pflegekonzept dient demnach der Orientierung und der Schaffung eines Rahmens, in dem der Mitarbeiter die Vorstellungen und Zielsetzungen der Gesamtorganisation erkennen kann. Ferner dient es zur Außendarstellung unserer Einrichtung, zur Transparenz und zur Orientierung der Patienten, Angehörigen, Betreuer und zuständigen Behörden. (Der Einfachheit halber wird im Weiteren nur noch von Patienten gesprochen, diese Definition trifft Behandlungs- und Grundpflegeleistungen zum großen Teil gleichermaßen)

Das hier vorliegende Konzept unterliegt einer dauerhaften Weiterentwicklung und Aktualisierung. Es wurde unter Beteiligung des Geschäftsführers, verantwortlichen Pflegefachkraft und der Qualitätsbeauftragten in Zusammenarbeit mit einer externen Beratungsfirma entwickelt und mit den Mitarbeitern des Pflegebereichs eingehend diskutiert, um Transparenz über die Inhalte zu schaffen.

Das Pflegekonzept löst die bisher gültige Pflegekonzeption ab, da sich pflegetheoretische Grundlagen weiterentwickelt und verändert haben. Viele Neuerungen wurden bereits umgesetzt und Prozesse optimiert; an der Einführung verschiedener anderer Maßnahmen wird intensiv gearbeitet.

Im strukturellen Bereich sind langfristig Entwicklungen umgesetzt worden. Ziel dabei war es, zeitgemäße Voraussetzungen zu schaffen, um eine noch individuellere und am Patient orientierte Pflege und Betreuung leisten zu können, denn dies steht im Vordergrund all unserer Bemühungen.

Das vorliegende Pflegekonzept dient allen Mitarbeitern als verbindliche Richtlinie für kundenorientiertes, qualitätsbewusstes und verantwortliches Handeln.

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Seite	Version	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		3	003	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LERNEN WEITERZUSAMMEN
Kennzeichen/Fundstelle: IV.2	Bezeichnung des Dokumentes: Pflegekonzept	

1. Kurzvorstellung des Intensivpflegedienstes /Darstellung von Räumlichkeiten

Unser Intensivpflegedienst ist am 06.05.2024 genehmigt wurden.

Unser Intensivpflegedienst will durch ein umfassendes Angebot von Leistungen im Bereich der häuslichen Pflege mit Rundum - Angeboten noch bessere Leistungen attraktiv für ältere und behinderte Menschen anbieten und erbringen.

Wir pflegen und arbeiten nach dem § 132I Abs. 5 SGB V zur Erbringung außerklinischer ambulanter Intensivpflege nach § 37c SGB V und dem SGB XI.

Unser Ziel ist es mit der häuslichen Intensivpflege eine aktivierende am Einzelfall orientierte speziell ausgerichtete Pflege in sehr guter Qualität auszuführen.

Die Hauptziele unserer pflegerischen Tätigkeit bestehen darin, durch Umsetzung aktivierender Pflege

- die Lebensqualität zu erhöhen bzw. zu sichern
- die Teilnahme am gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Leben anzubieten, zu fördern und anzuregen und somit allgemein die soziale Vereinsamung von Menschen zu lindern
- Hoffnung aufzubauen
- körperliche und geistige Aktivitäten zu fördern
- das hygienische Wohlbefinden zu sichern bzw. wieder herzustellen und
- eine geordnete Versorgung mit flüssigen und festen Nahrungsstoffen zu sichern und teilweise wieder die Selbstversorgung zu erlernen.
- Einbindung der Angehörigen in die ganzheitliche Pflege

Bei der Umsetzung unserer Hauptziele, als aktivierende individuelle Pflege, gehen wir grundsätzlich von der Ganzheitlichkeit von Körper, Geist und Seele aus, um so ganzheitliche Probleme am Menschen lokalisieren, und Beseitigung oder Linderung des Zustandes schaffen zu können.

Die Sorge um unsere Schutzbefohlenen, um ältere, behinderte und kranke Menschen, ist Sinn der Tätigkeit unserer wirtschaftlichen Unternehmung. Wichtig erscheint uns ebenso die Unterstützung bei der Bewältigung unterschiedlichster Lebenskrisen durch persönlichen Beistand anzubieten. Dies wird durch geschultes Personal derzeit schon umgesetzt, wir werden jedoch durch Weiterbildungen gerade das psychologisch einfühlsame Moment des Personals weiter stärken.

Räumlichkeiten:

Unser Pflegedienst hat seinen Hauptsitz in Leipzig und verfügt hier über genügend geeignete Räumlichkeiten zur Erfüllung seiner Aufgabe, die auch die Möglichkeit und Ausstattung zur Durchführung von Teambesprechungen bietet.

Wir sind 24 h / Tag unter folgender Telefonnummer zu erreichen – 03493/82 38 868 durch eine Rufumleitung .

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Seite	Version	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		4	003	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIRTSCHAFTS-UNIVERSITÄT WIEN
Kennzeichen/Fundstelle:	Bezeichnung des Dokumentes:	
IV.2	Pflegekonzept	

2. Zielgruppen, Aufnahme- und Ausschlusskriterien, Leistungsbeschreibung, Kooperationen,

Aufnahme in unserer Betreuung finden kranke- und pflegebedürftigen sowie intensivpflegebedürftigen Personen. Unsere Leistungen bestimmen sich nach den Leistungskomplexen, den ärztlichen VO zur Behandlungspflege bzw. den Wünschen der Pflegebedürftigen.

Eine Spezialisierung auf bestimmte Fallgruppen gibt es nicht. Es finden alle Personen Aufnahme, die in die zuvor genannten Kriterien einzuordnen sind, jedoch wird im Einzelfall durch den Geschäftsführer/Pflegedienstleitung entschieden, für welche Personen die Möglichkeit einer fachlichen Betreuung gegeben ist.

Eine Kooperation mit dritten findet zur Erfüllung unserer Leistungen vor allem mit Sanitätshäusern und anderen an der Pflege beteiligten statt, eine detaillierte Übersicht findet sich im QM-HB Fundstelle V.1.

Unsere Leistungen werden in einem Flyer beschrieben, dieser befindet sich bei der Fundstelle I.7 unseres QM-Handbuches.

3. Pflege theoretische Grundlagen, unser Pflegemodell

Unser erklärtes Ziel ist es, das wir nach dem Prinzip der vier Elemente des Strukturmodells zur Neuausrichtung der Pflegedokumentation arbeiten. Es wurde und werden Einrichtungsbezogene Dokumente und Prozesse erarbeitet sowie Vorlagen der Bundesregierung umgesetzt und in den Pflegealltag integriert.

Das sind die vier Elemente des Strukturmodells:

1. Die strukturierte Informationssammlung (SIS), welche als Einstieg in den Pflegeprozess mit der Einschätzung der pflegebedürftigen Personen dient.
2. ein individueller Maßnahmenplan
3. ein Bericht – Blatt mit dem Schwerpunkt ausschließlich auf Abweichungen aus der Maßnahmenplanung und damit des Alltags, sowie auf der Grundlage der SIS.
4. Zur Feststellung von Evaluationsdaten aus den Erkenntnissen der SIS, der Maßnahmenplanung und des Bericht – Blatt, erfolgt eine regelmäßige Evaluation nach den Vorgaben des hausinternen Qualitätsmanagement.

Das Grundprinzip:

Es erfolgt eine Konzentration auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Patienten und eine Stärkung der fachlichen Kompetenz aller an der Pflege beteiligten Fachkräfte.

Der personenzentrierte Ansatz dient als pflegewissenschaftliches Fundament.

Die Pflegefachkraft stellt die pflegerische Einschätzung übersichtlich dar. Hier finden Risiken und Phänomene, die sich aus der SIS ergeben Berücksichtigung.

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Seite	Version	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		5	003	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN WERTSCHÄTZEND
Kennzeichen/Fundstelle: IV.2	Bezeichnung des Dokumentes: Pflegekonzept	

Der Pflegebericht wird nur noch auf die Abweichungen der regelmäßig wiederkehrenden Maßnahmen der Pflege und Betreuung beschränkt.

Die Intensivpflege-Schindler-GmbH richtet die pflegerische Versorgung nicht mehr nach den AEDL's aus. Hier finden die sogenannten Themenfelder Anwendung.

Es werden pflegerische Hilfe- und Betreuungsbedarf, sowie die vorhandenen Ressourcen aufgenommen. Die biografischen Angaben werden hinsichtlich ihrer Bedeutung für die individuelle Pflege und Betreuung den pflegerischen Themenfeldern zugeordnet.

Die Risiken werden mit den Patienten besprochen, wobei hieraus individuelle Maßnahmen ergriffen.

Die sechs pflegebezogene Themenfelder:

1. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
2. Mobilität und Beweglichkeit
3. Krankheitsbezogene Anforderungen und Belastungen
4. Selbstversorgung
5. Leben in sozialen Beziehungen
6. Haushaltsführung

Es gibt Leitfragen und Leitgedanken, die als Orientierung für das Erstgespräch dienen.

Der fachgerechte Umgang mit pflegerelevanten Risiken ist ein weiteres zentrales Element zur qualitätsgesicherten Gestaltung des Pflegeprozesses.

Grundlage zur Einschätzung ist Fachlichkeit der Pflegekräfte des Pflegedienstes, wobei angemessen evidenzorientiert und -basiert des Fachwissen bei der Einschätzung zur Situation der pflegebedürftigen Person berücksichtigt.

Mit der Einführung der SIS in der Pflegedokumentation wird ein Paradigmenwechsel in der Struktur vorgenommen.

Die fachlichen Kompetenzen von Pflegefachkräften werden gestärkt und die Pflegedokumentation dient nicht mehr der Dokumentation für Prüfinstanzen, sondern fügt sich als ein Teil des pflegerischen Alltags in der Versorgung unserer Patienten ein.

Die Sichtweise der Patienten wird berücksichtigt und übersichtlich abgebildet. Angehörige können dazu einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie Informationen zum bisherigen sozialen Umfeld des alten Menschen beitragen, bei nonverbaler Kommunikation helfen und Auskunft über bestimmte Zusammenhänge, Vorlieben und Abneigungen geben.

Im Endeffekt bedeutet dies mehr Zeit für die direkte Pflege und Betreuung unserer Patienten.

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Seite	Version	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		6	003	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR SICHEN WERTSCHÜTZUNG
Kennzeichen/Fundstelle:	Bezeichnung des Dokumentes:	
IV.2	Pflegekonzept	

4. Pflegeleitbild unseres Pflegedienstes

Die Ziele unserer Pflege- und Betreuungsleistungen sind in unserem Pflegeleitbild enthalten. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, seine Handlungsweise an diesem Leitbild auszurichten; es dient demnach als verbindliche Arbeitsgrundlage.

„Der Mensch ist ein Individuum und steht im Mittelpunkt unseres pflegerischen Handelns.“

Wir scheuen nicht den öffentlichen Vergleich. Unser Pflegeleitbild ist allen zugänglich und hängt in unseren Einrichtungen öffentlich aus.

Wir entwickeln unser Qualitätsmanagementsystem stetig unter Einbeziehung unserer Mitarbeiter weiter und orientieren uns an der „Charta der Rechte der hilfe- und pflegebedürftiger Menschen“ 2005 und der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“ 2010.

5. Angaben zur Pflegeorganisation, unser Pflegesystem Bezugspflege, Personal

Die Form der Organisation der Pflege macht Angaben darüber, wie die Patienten durch uns gepflegt und betreut, also wie die Pflege geplant und umgesetzt wird. Nicht nur die Organisation der Prozesse wird durch die Entscheidung für das jeweilige Pflegesystem geprägt und beeinflusst, auch die Intensität, mit der die Individualität der Patienten, ihre Bedürfnisse, Wünsche, Probleme und Ressourcen in der Pflege berücksichtigt und umgesetzt werden, stehen in enger Verbindung zum Pflegesystem.

Um den Aufbau einer Vertrauensbasis zwischen Pflegebedürftigen und Mitarbeitern gewährleisten zu können, wird in unserer Einrichtung nach dem Prinzip der Ganzheitspflege gearbeitet.

Ganzheitspflege kann als nachvollziehbare, schriftlich fixierte Zuordnung von Patienten zu bestimmten Pflegemitarbeitern beschrieben werden. Für die Steuerung des Pflegeprozesses sind die Pflegefachkräfte zuständig, sie leiten Pflegehilfskräfte an, achten darauf, dass diese entsprechend der Pflegeplanung arbeiten und begleiten sie bei fachlichen Fragen. Im Rahmen der personellen und räumlichen Möglichkeiten werden die Patienten von den ihnen zugeordneten pflegerischen Mitarbeitern kontinuierlich, umfassend und individuell betreut.

Bei der Auswahl unserer Mitarbeiter achten wir auf deren fachliche und persönliche Eignung sowie Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Eigeninitiative. Pflegerische Hilfskräfte verfügen über die erforderliche Eignung sowie Kenntnisse und Fertigkeiten zur Pflege und Betreuung unserer Patienten und werden durch Pflegefachkräfte angeleitet.

In unserem Intensivpflegedienst arbeiten **Pflegefachkräfte** im Sinne unserer Pflegebedürftigen zusammen. Eine detaillierte Übersicht ist dem Organigramm und der Übersicht der Arbeitszeiten (Fundstelle II.1 und II.2 QM-Handbuch) zu entnehmen.

Die Planung der Pflege erfolgt in Anlehnung an die **Bezugspflege**, da eine Pflegefachkraft für eine bestimmte Anzahl von Patienten zuständig ist und deren Pflegeplanungen aktualisiert. Die Umsetzung der dort geplanten Maßnahmen erfolgt dann durch das gesamte Team, wobei im Rahmen der Alltagsorganisation angestrebt wird, den Pflegebedürftigen in der Gesamtheit seiner Bedürfnisse zu versorgen.

Leistungen der Behandlungspflege gehören zum pflegerischen Alltag.

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Seite	Version	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		7	003	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LERNEN VON FÜR ANDEREN
Kennzeichen/Fundstelle: IV.2	Bezeichnung des Dokumentes: Pflegekonzept	

6. Die Umsetzung des Pflegeprozesses

6.1 Das verwendete Pflegedokumentationssystem

Qualifizierte und professionelle Pflege erfordert ein entsprechendes Informations- und Dokumentationssystem. Dieses ist gesetzlich vorgeschrieben und bildet die Grundlage für eine nachvollziehbare, individuelle, bedürfnisorientierte und kontinuierliche Pflege.

Eine sorgfältig geführte Dokumentation dient als Arbeitsgrundlage, Arbeitsanweisung und Planungshilfe für alle am Pflegeprozess Beteiligten und vereinfacht die interdisziplinäre Information und Kommunikation, z. B. bei der Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten, Physiotherapeuten u. a.. Außerdem gewährleistet sie rechtliche Sicherheit und Leistungstransparenz gegenüber Qualitätsprüfungsinstitutionen.

Aus diesen Gründen wird in unserem Pflegedienst ein einheitliches, an unserem verwendeten Pflegemodell ausgerichtetes Dokumentationssystem genutzt. Es besteht aus mehreren Formularen, die von Vordruckherstellern bezogen werden bzw. von Mitarbeitern unseres Pflegedienstes in Zusammenarbeit mit einer Beratungsfirma entwickelt wurden.

Eine genaue Übersicht über die derzeit gültigen Formulare ist im Qualitätsmanagement-Handbuch bzw. in einer Mustermappe abgelegt.

7. Aufbau- und Ablauforganisation und innerbetriebliche Kommunikation, ständige Erreichbarkeit

Im Organigramm ist die Aufbauorganisation unseres Pflegedienstes schriftlich dargestellt, d. h. Organisationszusammenhänge, Unterstellungsverhältnisse und die Weisungsbefugnis der Mitarbeiter werden sichtbar. Das Organigramm ist für alle Mitarbeiter einsehbar im QM-Handbuch hinterlegt.

Um Offenheit und Transparenz auf allen Ebenen zu gewährleisten, ist die formelle Kommunikationsstruktur in unserem Pflegedienst so organisiert, dass regelmäßige Besprechungen bereichsübergreifend durchgeführt werden. Somit findet eine bewusste, interne Kommunikation auf festgelegten Wegen statt.

7.1 Darstellung der Verantwortung und Kompetenzen

Um zu gewährleisten, dass allen Mitarbeitern ihre Aufgaben und Kompetenzen bekannt sind, finden Stellenbeschreibungen, die auch Bestandteil des Arbeitsvertrages sind, Anwendung. Um sinnvoll und zielgerichtet arbeiten zu können, sind in den Stellenbeschreibungen Aufgabenbereiche definiert und Verantwortlichkeiten sowie Kompetenzen festgelegt.

Die Pflege wird unter ständiger Verantwortung einer leitenden Pflegefachkraft erbracht, die von einem entsprechend fachlich qualifizierten Stellvertreter unterstützt wird.

Hauptaufgaben der verantwortlichen Pflegefachkraft sind die Sicherstellung:

- der Pflege und Versorgung der Patienten
- der fachgerechten Führung der Pflegedokumentation
- der am Pflegebedarf orientierten Dienstplanung der Pflegekräfte

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Seite	Version	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		8	003	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LERNEN WERTSCHÄTZUNG
Kennzeichen/Fundstelle:	Bezeichnung des Dokumentes:	
IV.2	Pflegekonzept	

- von regelmäßigen Dienstbesprechungen im Pflegebereich
- der Anwendung von Qualitätsmaßstäben im Pflegebereich

7.2 Informationsweiterleitung und deren Sicherstellung

In unserem Pflegedienst wird ein verbindlicher und zuverlässiger Informationstransfer durch verschiedene Methoden gewährleistet.

Aktuelle patientenbezogenen Informationen werden unter Einbeziehung der Pflegedokumentation bei den regelmäßig stattfindenden **Dienstübergaben**, in den jeweiligen Teams vor Ort ausgetauscht. Die Zeiten für diese Dienstübergaben sind aus der Dienstplanlegende ersichtlich.

Zur Weitergabe patientenbezogener Informationen, die außerhalb unseres Dienstes benötigt werden (z. B. bei Verlegung ins Krankenhaus), nutzen unsere Mitarbeiter einen Pflegeüberleitungsbogen, auf dem alle aktuellen Informationen zur Pflegesituation eines Patienten schriftlich fixiert sind. Wir orientieren uns hierbei auch am nationalen Expertenstandard „Entlassungsmanagement in der Pflege“.

Die **Dienstberatungen** finden regelmäßig (4 x jährlich) statt. Inhalte sind hier vor allem die Weitergabe von speziellen Informationen aus multiprofessionellen Dienstberatungen, Fragen der Dienstplanung und -gestaltung sowie Informationen zu Neuerungen und Veränderungen von Standards und anderen Richtlinien.

Auftretende Fragen zur Pflege und Betreuung der Patienten werden geklärt und nach Lösungsmöglichkeiten für evtl. Probleme gesucht. Außerdem werden Fortbildungsinhalte besprochen oder Themen aus dem Bereich der Qualitätssicherung diskutiert. Fallbesprechungen finden ebenfalls statt. Interne Weiterbildungen mit Kurzvorträgen durch Mitarbeiter sind Bestandteil der Dienstberatung.

Um Informationen festhalten und bei Bedarf jederzeit einsehen zu können, werden bei allen Besprechungen Ergebnisprotokolle sowie Teilnehmerlisten geführt. Aktuelle Informationen, die den gesamten Dienst betreffen sowie Kurzmitteilungen hängen für alle Mitarbeiter einsehbar an den PIN-Wänden aus.

7.3 Dienstplanung und Einsatzplanung/ständige Erreichbarkeit

Die Dienstplanung und Einsatzplanung berücksichtigt eine kontinuierliche, an den Bedürfnissen der Patienten orientierte Pflege, Versorgung und soziale Betreuung.

Durch eine ausreichende Besetzung aller Dienste wird eine kompetente und gleich bleibende Pflege und Versorgung unserer Patienten gewährleistet. Die fachliche Aufsicht und Anleitung von Hilfspersonal ist durch die ständige unmittelbare Anwesenheit oder Erreichbarkeit einer Pflegefachkraft gesichert. Sie unterstützt die Pflegehilfskräfte in Notfallsituationen, bei den Dienstübergaben oder ist Ansprechpartner bei pflegefachlichen Fragen.

Für unsere Patienten sind wir Rund - um - die - Uhr erreichbar.

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Seite	Version	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		9	003	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN WERTSCHÄTZEND
Kennzeichen/Fundstelle: IV.2	Bezeichnung des Dokumentes: Pflegekonzept	

8. Einbeziehung von Angehörigen in die Pflege und Betreuung

Eine transparente Informationspolitik und Kontaktpflege gegenüber Angehörigen hinsichtlich der Pflege und Betreuung ist von großer Bedeutung, um die Kundenzufriedenheit auf beiden Seiten zu steigern.

In unserem Pflegedienst werden die Angehörigen als ein wichtiger Teil im Leben unserer Patienten angesehen. Sie stellen gewissermaßen ein Bindeglied zum früheren Leben unserer Patienten dar und leisten oft einen eigenen Beitrag im Pflegegeschehen. Es ist deshalb für uns selbstverständlich, mit Angehörigen oder Betreuern eng zu kooperieren, um die Interessen unserer Patienten bestmöglich im Pflegeprozess berücksichtigen zu können.

Angehörige werden jederzeit auf Wunsch und entsprechend ihrer individuellen Möglichkeiten in die Pflege und Betreuung unserer Patienten mit einbezogen. Unser Auftrag hierbei bezieht sich auch auf die fachliche Anleitung. Oft fehlen Angehörigen der fachliche und pflegerische Hintergrund, das Wissen und das Verständnis für die Umsetzung bestimmter Pflegemaßnahmen und -techniken. Zudem wird eine intensive Begleitung durch Familienmitglieder während der Sterbephase ermöglicht und durch unsere Mitarbeiter einfühlsam unterstützt.

Beim Erstgespräch und bei der Aufnahme werden Angehörige integriert, da gerade diese Situation als ein erster Schritt des gegenseitigen Kennenlernens auf alte Menschen oft beängstigend wirkt. Möglicherweise können sie die Vielzahl von neuen Informationen nicht gleich erfassen und verarbeiten, was in späteren Situationen dazu beiträgt, dass Entscheidungen nicht adäquat getroffen werden können. Hier kann die Anwesenheit von vertrauten Personen beruhigend wirken und Ängste abbauen.

Hilfreich ist die Anwesenheit von Angehörigen auch bei der Erhebung von biografischen Daten, da die Angehörigen mit dem alten Menschen vertraut sind und seine Vorlieben und Bedürfnisse genau kennen.

So bieten wir auch Beratungen sowie Hilfeleistungen beim Kontakt mit Behörden und Ämtern sowie bei der Verwaltung von Barbeträgen an.

9. Angaben zum Qualitätssicherungssystem

Unter Beachtung des § 112 SGB XI und der „Gemeinsamen Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung einschließlich des Verfahrens zur Durchführung von Qualitätsprüfungen nach § 112 SGB XI in ambulanten Pflegeeinrichtungen“ stellen wir uns den Anforderungen der Qualitätssicherung. Als Pflegedienst sind wir somit gesetzlich verpflichtet, ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen und weiterzuentwickeln. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird im Rahmen von Qualitätsprüfungen durch unabhängige Sachverständige untersucht.

Externe Qualitätsberatung und -prüfung steht demnach in engem Zusammenhang mit den Einrichtungsinternen Anstrengungen zur Qualitätssicherung, um Leistungsqualität von innen, also aus unserem Pflegedienst selbst heraus, zu entwickeln, nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln.

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Seite	Version	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		10	003	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LERNEN. WIR BEWERTEN. WIR VERBESSERN.
Kennzeichen/Fundstelle: IV.2	Bezeichnung des Dokumentes: Pflegekonzept	

9.1 Interne Qualitätssicherung

Unter Interner Qualitätssicherung versteht man alle Bemühungen des Dienstes selbst, die Qualität ihrer Leistungen zu sichern und weiter zu entwickeln. Die zentralen Elemente der **Internen Qualitätssicherung** werden in den nachfolgenden Abschnitten kurz beschrieben.

9.1.1 Einsatz von Qualitätsbeauftragten

Um die Umsetzung dieses Systems zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung zu gewährleisten, ist ein Qualitätsbeauftragter eingesetzt, der in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und unter Beteiligung aller Mitarbeiter das Qualitätsmanagementsystem installiert und weiter entwickelt, um eine ständige Verbesserung unserer Leistungen zu bewirken.

Der Qualitätsbeauftragte berät und unterstützt die Leitung des Pflegedienstes sowie die Mitarbeiter hinsichtlich des Qualitätsmanagements, der Qualitätssicherung und der Qualitätsentwicklung. Er arbeitet an der kontinuierlichen Implementierung des Qualitätssystems, koordiniert und betreut Projekte des Qualitätsmanagements und erarbeitet Verfahrensanweisungen und Standards.

9.1.2 Qualitätszirkel

Zur Umsetzung eines kontinuierlichen Qualitätssicherungsprozesses ist in unserem Pflegedienst eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich schwerpunktmäßig und aktuell mit unterschiedlichen Fragestellungen befassen, die sich aus der Pflege und Betreuung unserer Patienten ergeben. Dieser Zirkel besteht aus ca. 3 Mitarbeitern, meist aus verschiedenen Berufsgruppen, die in unterschiedlichen Abständen zusammenkommen.

Ziel ist es kundenorientierte, dauerhafte, möglichst wirtschaftliche und Mitarbeiter freundliche Lösungsmechanismen für auftretende Probleme zu schaffen und diese verbindlich und einheitlich für unseren Pflegedienst festzulegen.

9.1.3 Fachliche Überprüfung der Pflege

Das Ergebnis der Pflege und Versorgung wird in unserem Pflegedienst in regelmäßigen Abständen (aller halbe Jahre) durch Pflegevisiten überprüft. Diese stellen ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung in unserer Einrichtung dar, da sie eine Möglichkeit bieten, den Pflegeprozess zu bewerten und zu beurteilen, die Umsetzung von Standards und Vorgaben zu überprüfen und die Kommunikation zwischen Pflegebedürftigen und Mitarbeitern zu fördern. Insbesondere wird darauf geachtet, inwieweit die aktivierende Pflege zielorientiert durchgeführt wird sowie die individuellen Wünsche und Bedürfnisse des Patienten berücksichtigt wurden.

Während der Pflegevisiten, die durch die Pflegedienstleitung oder andere speziell qualifizierte Mitarbeiter durchgeführt werden, werden u. a. die Qualität der Pflegedokumentation überprüft und ein Gespräch mit dem Pflegebedürftigen geführt, um den Grad der Zufriedenheit zu ermitteln sowie Defizite erkennen und zukünftig beseitigen zu können.

Hinweise aus den Pflegevisiten werden schriftlich dokumentiert, mit dem verantwortlichen Mitarbeiter besprochen und in regelmäßigen Abständen während der Dienstberatungen ausgewertet.

9.1.4 Entwicklung und Anwendung von Pflegestandards

Im Rahmen der Qualitätssicherung wurden in unserem Pflegedienst Standards für Maßnahmen der Grund- und Behandlungspflege sowie zur sozialen Betreuung entwickelt, die in der täglichen Arbeit

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Seite	Version	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		11	003	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN WERTSCHÄTZUNG
Kennzeichen/Fundstelle: IV.2	Bezeichnung des Dokumentes: Pflegekonzept	

Anwendung finden und entsprechend neuester pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse bspw. von Expertenstandards optimiert und angepasst werden. Diese Standards spiegeln professionelle Wertvorstellungen, definieren Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der Pflegenden wider und beschreiben das festgelegte Niveau der pflegerischen Versorgung. Pflegerisches Handeln wird dadurch transparenter und die Leistung der Pflegenden wird sicht- und messbar.

Mit der Entwicklung neuer Standards und der Optimierung bereits bestehender Standards, Leit- und Richtlinien beschäftigt sich in unserem Pflegedienst der Qualitätszirkel. Er passt neue Erkenntnisse den individuellen Gegebenheiten unseres Dienstes an und ist in die Gestaltungs- und Entscheidungsvorgänge eingebunden. (Nationale Expertenstandards/Grundsatzstellungen des MDS Essen)

9.1.5 Risikomanagement

Um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren, sind in unserem Pflegedienst verschiedene Controllinginstrumente implementiert.

Besondere Priorität wird der Erfassung von pflegerischen Risiken beigemessen, um zeitnah und gezielt reagieren zu können.

So erheben wir nach vorgegebenem Schema 1 x monatlich die Patienten, die mit pflegerischen Risiken behaftet sind (bspw. niedriger BMI/Dekubitusrisiko/ Kontrakturen/Katheter etc.).

Um die Qualität in der Einarbeitungsphase neuer Mitarbeiter sicherzustellen, liegt ein speziell erarbeitetes Konzept vor, das Angaben über Ziele, Organisationsstruktur, Organisationsabläufe und Besonderheiten enthält und eine gezielte und individuelle Beurteilung und Begleitung des Mitarbeiters während der Einarbeitungsphase ermöglicht.

9.1.6 Umgang mit Beschwerden oder Hinweisen

Kundenwünsche sind die Messlatte für die Qualität unserer Leistungen. Um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten oder wiederherzustellen ist in unserer Einrichtung ein offener Umgang mit Beschwerden oder Hinweisen selbstverständlich. Die Auswertung von Beschwerden und Hinweisen hilft uns, eigene Schwachstellen zu erkennen und Qualitätsverbesserungen zu erreichen.

Alle eingehenden Beschwerden werden mit Hilfe eines standardisierten Beschwerdeboogens schriftlich erfasst, entsprechend weitergeleitet und bearbeitet. Der Beschwerdeführer erhält selbstverständlich zeitnah eine Rückmeldung über die zur Abstellung des Problems veranlassten Maßnahmen.

In regelmäßigen Abständen erfolgt in den Dienstberatungen eine Auswertung der eingegangenen Beschwerden, um die Mitarbeiter diesbezüglich zu informieren und zu sensibilisieren und künftig Probleme gleicher oder ähnlicher Art zu verhindern.

9.1.7 Patienten- und Mitarbeiterbefragungen

Die Qualität der Patientenversorgung und die Zufriedenheit der uns anvertrauten Menschen haben oberste Priorität. Wenn wir langfristig gute Leistungen einer Vielzahl von Patienten anbieten wollen, bedeutet dies, Wege zu finden, wie wir Kunden an uns und unsere Vorstellungen von Qualität binden können.

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Seite	Version	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		12	003	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WACHSTUM DURCH WISSEN
Kennzeichen/Fundstelle:	Bezeichnung des Dokumentes:	
IV.2	Pflegekonzept	

Um den Grad der Zufriedenheit unserer Patienten zu ermitteln, Hinweise für Verbesserungsmöglichkeiten zu erhalten und evtl. Schritte zur Fehlervermeidung einleiten zu können, führen wir in regelmäßig wiederkehrenden Abständen Patientenbefragungen mit Hilfe anonymisierter Fragebögen durch. Die Ergebnisse dieser Befragungen werden wir veröffentlichen und in den Dienstberatungen ausgewertet.

Wir beabsichtigen außerdem, in regelmäßigen Abständen Mitarbeiterbefragungen in unserer Einrichtung durchzuführen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu ermitteln sowie Vorschläge und Ideen zur Optimierung von Abläufen oder zur Veränderung von Rahmenbedingungen zu sammeln. Ziel dabei ist es, den IST-Stand zu erheben, Mitarbeitererwartungen festzustellen und innere Motivation bei unseren Mitarbeitern zu schaffen.

9.2 Externe Qualitätssicherung

Maßnahmen der externen Qualitätssicherung sind alle Maßnahmen, die von außen in Form von Überprüfung und Kontrolle auf die interne Qualitätssicherung bzw. Qualitätsentwicklung einer Pflegeeinrichtung einwirken.

Unser Pflegedienst nutzt im Bereich der Qualitätssicherung die Dienste einer externen Beratungsfirma, um die Umsetzung, Eignung und Funktionstüchtigkeit der eingeführten Elemente des Qualitätsmanagementsystems zu überprüfen.

Hinweise, die sich aus Qualitätsprüfungen des MDK oder anderen Prüfinstitutionen ergeben, werden genutzt, um Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten.

Außerdem nimmt unsere Einrichtung an einem externen Qualitätszirkel teil, um einen aktuellen Austausch zu Fragen des Qualitätsmanagements zu pflegen.

10. Fort- und Weiterbildung

Fort- und Weiterbildungen unserer Mitarbeiter sind ein zentraler Bestandteil der Personal- und Qualitätsentwicklung in unserer Einrichtung. Da sich das Wissen gerade im pflegerischen Bereich sehr schnell weiterentwickelt, kommt diesem Bereich eine besondere Bedeutung zu.

In unserem Pflegedienst liegt ein Fort- und Weiterbildungskonzept vor, welches systematisch und strukturiert Auskunft darüber gibt, welche Fortbildungen im Bereich der Pflege angeboten werden. Damit wird Transparenz zu allen Aspekten der Fortbildung gewährleistet. Dieses Konzept trägt dazu bei, Wissenslücken gezielt zu beseitigen, die Qualität in der Pflege zu steigern und zu sichern. Die genauen Termine der im Konzept beschriebenen Veranstaltungen werden in einem gesonderten Fortbildungsplan allen Mitarbeitern bekannt gegeben. Dieser Fortbildungsplan wird jährlich prospektiv erarbeitet und ergänzt, so dass zum Jahresende ein Nachweis über den Umfang der Bildungsleistungen vorliegt.

Fortbildungen finden entweder intern in unserem Pflegedienst statt oder es erhalten Mitarbeiter die Möglichkeit, an externen Veranstaltungen teilzunehmen. Um den Transfer in die Praxis zu gewährleisten, werden Inhalte der besuchten Fortbildungen im Rahmen der Teambesprechungen weitergegeben.

Schulungen von Zulieferfirmen hinsichtlich ihrer Produkte finden in der Regel gezielt im Pflegedienst statt. Die Teilnahme von Mitarbeitern an berufsbegleitenden Weiterbildungen wird entsprechend Einrichtungsbezogener Bedürfnisse unterstützt.

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Seite	Version	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		13	003	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIN LERNEN WERTSCHÄTZUNG
Kennzeichen/Fundstelle: IV.2	Bezeichnung des Dokumentes: Pflegekonzept	

Pflegerelevante Fachliteratur steht unseren Mitarbeitern im Endleihsystem zur Verfügung. Unser Pflegedienst verfügt außerdem über periodisch erscheinende Fachzeitschriften, in welche bei Interesse Einsicht genommen werden kann.

Literaturangaben

Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Berlin:

Leitfaden zur Erstellung einer Pflegekonzeption – vollstationäre, teilstationäre und Kurzzeitpflege Einrichtungen. 2001

König, Jutta:

Was die PDL wissen muss. Das etwas andere Qualitätshandbuch in der Altenpflege. Hannover. 2003

Löser, Angela:

Pflegekonzepte nach Monika Krohwinkel. Pflegekonzepte in der stationären Altenpflege erstellen: Schnell, leicht und sicher. 2. Auflage. Hannover 2004

Sittler, Engelbert; Kruft, Marianne:

Handbuch Altenpflege. 2. Auflage. München. 2004

Hinweise des Landespflegeausschusses zur Gestaltung von Pflegekonzepten

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Seite	Version	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		14	003	Verw./MA